

Thuật ngữ

5K: Sự kiện chạy/cuộc đua (3,1 dặm)

10K: Sự kiện chạy/cuộc đua (6,2 dặm)

Bắt cóc: Thuật ngữ định hướng giải phẫu có nghĩa là di chuyển ra khỏi cơ thể.

Acetabulum: Vị trí của xương chậu mà đầu xương đùi nằm trong đó.

Acetyl-CoA: Một phân tử là kết quả của quá trình oxy hóa axit béo, axit amin và pyruvate. Acetyl-CoA được chia nhỏ và sử dụng để sản xuất năng lượng trong Chu trình Krebs.

ACSM: Trường Cao đẳng Y học Thể thao Hoa Kỳ

Quy trình Acromion: Phần xương của xương bả vai kéo dài phía trên khớp vai. Nó được nối với xương đòn thông qua Khớp Acromioclavicular (Khớp AC).

Tính cộng: Thuật ngữ định hướng giải phẫu có nghĩa là di chuyển về phía cơ thể.

Adenosine Triphosphate (ATP): Một phân tử chịu trách nhiệm lưu trữ và giải phóng năng lượng trong cơ thể. Do đó, các nhà sinh học đã đặt tên cho ATP là "Đồng tiền của sự sống". ATP được tạo ra trong ty thể của tế bào. ATP có thể được sản xuất trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Cơ thể chỉ lưu trữ một lượng nhỏ ATP tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó ATP phải được tái tạo liên tục ở cấp độ tế bào.

AED: Máy khử rung tim ngoài tự động. Thiết bị cầm tay được sử dụng để chẩn đoán nhịp tim và cung cấp một cú sốc điện tử nếu cần thiết để thiết lập lại nhịp tim bình thường.

Hiệp khí: Cần oxy

Chất chủ vận: Cơ hoặc các cơ chịu trách nhiệm chính cho chuyển động xung quanh khớp. Còn được gọi là "động cơ chính".

Phế nang: Các túi khí trong phổi tượng trưng cho điểm cuối của đường hô hấp.

Kỵ khí: Thuật ngữ này có nghĩa là "không có oxy". Đây là một cách gọi sai nhẹ vì ở trạng thái kỵ khí thường liên quan nhiều hơn đến việc thiếu oxy được sử dụng hơn là không có oxy.

Chất đối kháng: Cơ hoặc các cơ hoạt động đối lập với (các) cơ Agonist

Trước: Thuật ngữ định hướng giải phẫu đề cập đến phía trước hoặc phía trước cơ thể.

Cột sống chậu trước trên (ASIS): Phần trước xa nhất của xương chậu (hai bên). Thường được sử dụng làm mốc để đánh giá.

Nhân trắc học: Phép đo một vị trí hoặc vị trí trên cơ thể con người.

Bộ xương phụ: Bao gồm 126 xương, những xương này chịu trách nhiệm vận động.

Động mạch: Vận chuyển máu giàu oxy từ tim đến cơ thể.

Hen suyễn: Một phản ứng viêm mãn tính của đường hô hấp.

Teo cơ: Giảm kích thước cơ. Thường do không hoạt động kéo dài.

Hệ thống thần kinh tự trị (ANS): Kiểm soát các cơ co thắt của tim và cơ trơn và không đòi hỏi suy nghĩ có ý thức như hệ thần kinh trung ương. ANS bao gồm hai hệ thống thần kinh, giao cảm và phó giao

cảm, có chức năng tự điều chỉnh cơ thể.

Bộ xương trục: Bao gồm 80 xương, bộ xương trục cung cấp cấu trúc trung tâm của cơ thể. Các bộ phận chính của bộ xương trục bao gồm hộp sọ, cột sống, xương sườn và xương ức.

Kéo căng đạn đạo: Một kiểu kéo giãn thụ động bao gồm các chuyển động "nảy" hoặc nhanh. Kiểu kéo giãn này không được khuyến khích do có khả năng gây chấn thương cao.

Lớp lót: Loại quần áo thể thao được mặc sát da nhằm mục đích thấm mồ hôi và giữ cho da khô ráo.

Huấn luyện cơ bản: Luyện tập thường được thực hiện nhằm mục đích tăng cường thể lực và sức bền. Đặc trưng bởi cường độ thấp đến trung bình và ở tốc độ ổn định.

Bắp tay Brachii: Cơ hai đầu cánh tay uốn cong khuỷu tay. Cơ bắt nguồn từ xương bả vai và xương cánh tay và bám vào cẳng tay (bán kính/xương trụ).

Song phương: Liên quan đến chuyển động của cả hai bên cơ thể.

Đánh giá trở kháng điện sinh học (BIA): Loại đo thành phần cơ thể sử dụng xung điện mức thấp. Dựa trên khả năng chống lại dòng điện, có thể xác định được thành phần cơ thể.

Cơ sinh học: Nghiên cứu về cơ chế hoạt động của cơ thể con người

Máy phân tích Lactate trong máu: Một thiết bị phân tích một mẫu máu nhỏ để xác định mức độ lactate trong máu. Được sử dụng để xác định các thông số mức nỗ lực đào tạo.

Chỉ số khối cơ thể (BMI): BMI được tính bằng công thức nhằm xác định xem một cá nhân đang thiếu cân, cân nặng trung bình hay thừa cân. Điều này được xác định bằng cách so sánh chiều cao và cân nặng của một cá nhân. BMI không phải là một công cụ chính xác để sử dụng cho một vận động viên vì nó không tính đến lượng mỡ hoặc cơ trong cơ thể.

Brachioradialis: Cơ cẳng tay kéo dài cổ tay.

Kiệt sức: Trạng thái tinh thần mà một cá nhân mất hứng thú với một hoạt động và thường đi kèm với tình trạng kiệt sức.

Viêm bao hoạt dịch: Viêm túi bao hoạt dịch. Túi bursa là một túi chứa đầy chất lỏng hoạt dịch nằm giữa xương và gân, hoặc gân và da. Mục đích của túi bursa là cung cấp đệm và giảm ma sát.

Nhịp bước: Được sử dụng để mô tả tốc độ di chuyển của chân mà một cá nhân chạy. Thường được biểu thị bằng số bước mỗi phút.

Bắp chân: Cơ phía sau xương (xương chày) của cẳng chân. Bao gồm cơ bụng và cơ gót.

Mao mạch: Các mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể. Chúng tăng mật độ dựa trên lượng máu cần cung cấp ở một khu vực cụ thể. Chúng được tìm thấy trong các mô của cơ thể con người và vận chuyển máu từ động mạch đến tĩnh mạch. Do thành mao mạch mỏng nên O₂, CO₂, chất thải và chất dinh dưỡng có thể đi qua thành mao mạch.

Carbohydrate: Bao gồm chủ yếu là đường và tinh bột. Carbohydrate tạo thành một trong ba loại chất dinh dưỡng chính được cơ thể sử dụng làm năng lượng. Carbohydrate thường được phân loại thành Đơn giản và Phức tạp. Việc phân loại phụ thuộc vào cấu trúc hóa học của thực phẩm và tốc độ tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể.

Nạp carbohydrate: Đặc trưng bằng việc ăn thêm carbohydrate trong những ngày trước khi diễn ra sự

kiện và làm giảm khối lượng tập luyện. Mục tiêu của việc nạp carb là tối đa hóa hiệu suất sức bền bằng cách tăng mức glycogen của cơ. Lượng glycogen dự trữ càng lớn thì hoạt động hiếu khí càng kéo dài.

Tim trôi: Một hiện tượng liên quan đến sự gia tăng tự nhiên hoặc "trôi" nhịp tim đi lên trong khi cường độ tổng thể (tức là nhịp thở, mức nỗ lực, lượng calo đốt cháy) vẫn giữ nguyên.

Cơ tim: Chỉ nằm trong tim và chịu trách nhiệm duy nhất cho việc co bóp/thu giãn tim để bơm máu đến phổi và phần còn lại của cơ thể

Cung lượng tim: Lượng máu được bơm ra khỏi tim trong một phút.

Sụn: Sụn chủ yếu được tạo thành từ collagen và nước và không được cung cấp bởi máu hoặc dây thần kinh. Có ba loại sụn; Hyaline (khớp), Sụn sợi và Đàn hồi. Liên quan đến chuyển động, điều quan trọng nhất cần lưu ý là sụn Hyaline. Sụn hyaline được tìm thấy trên bề mặt của hầu hết các khớp. Sụn hyaline bảo vệ các khớp và hoạt động như một rào cản giữa các xương.

Hệ thống thần kinh trung ương (CNS): CNS là một hệ thống thần kinh tự nguyện, nghĩa là nó cần có suy nghĩ có ý thức để được kích hoạt. Não gửi tín hiệu đến các tế bào thần kinh vận động để điều khiển các sợi cơ, do đó tạo ra các cơn co thắt cơ xương.

Cột sống cổ: Phần cao nhất của cột sống. Cột sống cổ được tạo thành từ 7 đốt sống, C1-C7. Con số càng cao thì đốt sống càng gần đầu.

Vòng tròn: Sự kết hợp của dang, khép, gấp và duỗi. Di chuyển một chi theo chuyển động tròn tương trưng cho chuyển động quay vòng.

Xương đòn: Thường được gọi là xương đòn. Kết nối xương ức và xương bả vai.

Hồ sơ khách hàng: Mục đích của hồ sơ khách hàng là thu thập nhiều thông tin khác nhau để đánh giá/huấn luyện họ tốt hơn và chính xác hơn.

Bài tập chuỗi khép kín: Bài tập trong đó tay hoặc chân cố định và không thể cử động.

Coccyx: Thường được gọi là "xương cụt", xương cụt được tạo thành từ 3-5 xương hợp nhất và tượng trưng cho phần đáy của cột sống.

Tắt nén: Tắt kéo dài đến gần hết bắp chân và "nén" cơ bắp chân. Được cho là hỗ trợ giảm rung cơ, tăng lưu lượng máu quay trở lại tim và phục hồi cơ bắp.

Đồng tâm: Sự co lại của cơ tạo ra lực.

Đối diện: Ở phía đối diện của một cấu trúc khác. Nâng cánh tay phải là đối diện với chân trái.

Cơ bắp cốt lõi: Các cơ có liên quan đến việc ổn định và hỗ trợ xương chậu và cột sống. Các cơ cốt lõi bao gồm: Cơ bụng thẳng, cơ xiên ngoài, cơ xiên trong, cơ bụng ngang, cơ dựng cột sống, cơ gấp hông (psoas) và cơ mông.

Chu trình Cori: Con đường trao đổi chất trong đó lactate được tạo ra nhờ quá trình glycolysis kỵ khí trong cơ, di chuyển đến gan và được chuyển hóa thành glucose, sau đó quay trở lại cơ để được chuyển đổi trở lại thành lactate.

CPR: Hồi sức tim phổi. Mục đích của CPR là cung cấp một phần máu và oxy đến tim và não.

Creatine Phosphate (CP): Một hợp chất phosphate năng lượng cao hỗ trợ quá trình tái tổng hợp ATP.

Huấn luyện chéo: Bất kỳ bài tập nào được thực hiện nhằm mục đích rèn luyện mà không bao gồm chạy.

Sâu: Thuật ngữ định hướng dùng để mô tả một cấu trúc nằm cách xa bề mặt của một cá thể.

Mất nước: Nguyên nhân là do một người không hấp thụ chất lỏng với tốc độ như mức tiêu hao. Tình trạng mất nước có thể ở mức độ từ nhẹ đến rất nặng và có thể dẫn đến tử vong.

Đau nhức cơ khởi phát muộn (DOMS): Đau nhức cơ đạt đến mức đau nhức cao nhất 24-48 giờ sau khi buổi tập luyện kết thúc. Thể hiện chủ yếu là kết quả của các chuyển động liên quan đến lập dị.

Deltoids: Cơ vai. Thông thường không được sử dụng để mô tả các cơ của chóp xoay.

Trầm xuống: Chuyển động đi xuống của bộ phận cơ thể

Giải miễn cảm: Mục đích của giải miễn cảm là giảm và/hoặc loại bỏ nỗi ám ảnh thông qua việc tiếp xúc nhiều lần và tăng cường với nỗi ám ảnh.

Giảm tập luyện: Khoảng thời gian hoạt động giảm đáng kể hoặc thiếu hoạt động thể chất. Tương quan với việc giảm mức độ tập thể dục.

Cơ hoành: Cơ hoành là một tấm cơ "hình vòm" nằm giữa khoang ngực và khoang bụng, chịu trách nhiệm tương ứng cho việc tăng giảm kích thước phổi khi hít vào (co cơ hoành) và thở ra (thư giãn cơ hoành). Cơ hoành cũng mang lại sự ổn định cho vùng thắt lưng bằng cách hoạt động với các cơ cốt lõi Bộ phận Bên trong khác.

Xa: Cách xa điểm gắn kết, xa hơn từ trung tâm cơ thể. Xương chày nằm xa xương đùi.

Gập lưng: Giảm góc giữa cẳng chân và bàn chân. Đi bằng gót chân khiến bàn chân bị uốn cong.

Duỗi động: Giãn cơ trong đó có sự chuyển động để tạo điều kiện cho việc giãn cơ.

Co cơ lệch tâm: Kéo dài cơ và thường được sử dụng như một lực "hãm" để chống lại sự co cơ đồng tâm.

Chất điện giải: Khoáng chất phân hủy thành các hạt tích điện nhỏ gọi là ion. Có mặt ở bất cứ nơi nào có nước trong cơ thể bạn, chất điện giải sẽ điều hòa chất lỏng của cơ thể, giúp duy trì cân bằng độ pH trong máu khỏe mạnh và tạo ra các xung điện cần thiết cho mọi khía cạnh của hoạt động thể chất - từ chức năng tế bào cơ bản đến các tương tác thần kinh cơ phức tạp cần thiết cho hoạt động thể thao. Thận có tác dụng giữ nồng độ chất điện giải trong máu không đổi bất chấp những thay đổi trong cơ thể. Một trong nhiều chất điện giải quan trọng là natri.

Chuỗi vận chuyển điện tử: Diễn ra trong màng ty thể và là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn oxy hóa. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn việc tạo ra ATP.

Độ cao: Chuyển động đi lên của (các) bộ phận cơ thể

Tiêu thụ oxy quá mức sau khi tập thể dục (EPOC): Lượng oxy nạp vào sau khi ngừng tập luyện. Mục đích của EPOC là loại bỏ tình trạng thiếu oxy.

Erector Spinae: Còn được gọi là Extensor Spinae, nhóm cơ và gân này chạy song song với cột sống từ gốc (thắt lưng) đến phần trên cùng (cổ). Các cơ tạo nên cơ dựng cột sống là: Iliocostalis (Bên), Longissimus (Trung tâm), Spinalis (Trung gian). Chức năng chính là duỗi và uốn cong bên của cột sống. Thứ hai, nó cung cấp sự ổn định đẳng cự cho cột sống.

Đảo ngược: Hướng ra ngoài. Khi lòng bàn chân hướng ra ngoài thì bàn chân bị lộn ngược.

Mở rộng: Tăng góc khớp

Cơ bụng ngoài: Cơ này nằm ở hai bên của cơ thẳng bụng và chịu trách nhiệm uốn cong cột sống cũng như uốn cong và xoay sang bên (uốn cong từ bên này sang bên kia) của phần trên cơ thể. Giống như cơ thẳng bụng, nó thứ hai hỗ trợ ổn định cột sống thất lưng thông qua sự co đẳng cự.

Fartlek: Từ tiếng Thụy Điển: Chơi tốc độ. Được các vận động viên chạy bộ sử dụng để mô tả quá trình tập luyện có những thay đổi về nhịp độ, thường không có cấu trúc.

Màng: Một mạng mô liên kết 3D bao quanh tất cả các cơ, xương, dây thần kinh và mạch máu. Có ảnh hưởng lớn đến tư thế và sự cân bằng cơ bắp. Cân cơ bị hạn chế tạo ra đau đớn và rối loạn chức năng cơ.

Sợi cơ co giắt nhanh: Thường được gọi là sợi "Loại II", sợi cơ co giắt nhanh được chia thành hai loại: IIA và IIB. Đặc điểm cơ bản của các sợi cơ co giắt nhanh là chúng co với lực lớn nhưng thiếu khả năng bắn liên tục mà không bị mỏi. Sợi cơ giắt nhanh không bị oxy hóa, nghĩa là chúng không cần oxy để co lại.

Chất béo: Nguồn năng lượng chính cho cơ thể trong những trận đấu sức bền kéo dài. Vị trí chính để lưu trữ chất béo là mô mỡ (tức là mỡ trong cơ thể) trong cơ thể. Phần lớn mô mỡ được sử dụng làm năng lượng được gọi là mỡ dưới da (dưới da). Mô mỡ bao gồm Tế bào mỡ hay tế bào mỡ. Tế bào mỡ là nơi lưu trữ và tổng hợp chất béo trung tính.

Xương đùi: Xương duy nhất ở đùi. Kết nối xương chậu với xương chày/đầu gối.

Bàn chân phẳng: Bàn chân phẳng thường được gọi là vòm "ngã" hoặc "sụp đổ". Những người có bàn chân bẹt có rất ít hoặc không có vòm bàn chân khi đứng. Những người nằm sắp quá mức thường có "bàn chân bẹt" nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Độ uốn: Giảm góc khớp

Chạy nổi: Về cơ bản là Lặp lại nhưng thay vì chạy bộ nhẹ nhàng giữa các lần nỗ lực, tốc độ vẫn tương đối cao. Các bài tập phao rèn luyện cơ thể để có thể phản ứng với những đợt tăng vọt giữa cuộc đua mà không bị tụt xuống dưới tốc độ cuộc đua.

Con lăn xốp: Về cơ bản là một ống Styrofoam tròn, bán cứng. Con lăn bọt có nhiều mức độ cứng cũng như chiều dài khác nhau. Ý tưởng đằng sau con lăn xốp là chúng được đặt dưới một vùng cơ hoặc vùng mô liên kết căng cứng và cơ thể "lăn" trên một vùng bị căng cho đến khi vùng đó trở nên bớt hạn chế và căng hơn.

Lực: Chuyển động đẩy hoặc kéo giữa hai vật. Tích của khối lượng và gia tốc.

Bài tập cơ bản: Một loạt các bài tập sức bền kết hợp với nhau để tạo nền tảng sức mạnh vững chắc cho các vận động viên sức bền

Gãy xương: Gãy xương. Thường do va chạm hoặc căng thẳng lặp đi lặp lại.

Ma sát: Lực tác dụng lên diện tích tiếp xúc giữa hai bề mặt theo hướng ngược lại với chuyển động hoặc xu hướng chuyển động.

Mặt phẳng phía trước: Chia cơ thể thành hai nửa trước và sau. Bước sang một bên là một chuyển động trong mặt phẳng phía trước.

Điểm tựa: Điểm tựa mà đòn bẩy xoay trên đó.

Huấn luyện chức năng: Các bài tập rèn luyện sức đề kháng bất chước phạm vi chuyển động của hoạt

động đang được huấn luyện.

Gastrocnemius: Cơ nông, nằm ở phía trên cơ dẹt và phía sau xương chày. Có tác dụng uốn cong lòng bàn chân và ổn định mắt cá chân.

Hội chứng thích ứng chung (GAS): Được phát triển bởi Hans Selye, GAS mô tả cách các cá nhân thích ứng với căng thẳng và bao gồm ba giai đoạn: Báo động, Kháng cự và Kiệt sức. Việc áp dụng GAS vào việc rèn luyện thể chất cho thấy cơ thể có thể khỏe hơn dù thích nghi với căng thẳng nhưng một khi căng thẳng lên quá cao, cơ thể sẽ bắt đầu suy sụp.

Đo chu vi: Đo (chu vi) một bộ phận cơ thể

Khớp Glenohumeral: Khớp vai

Glucose: Đường huyết. Nguồn năng lượng cho tế bào của cơ thể

Cơ mông: Bao gồm gluteus maximus, gluteus medius và gluteus minimus. Vai trò chính của cơ mông là hỗ trợ LPHC, kéo dài và xoay hông ra bên ngoài.

Glycogen: Dạng dự trữ carbohydrate chính trong cơ thể (cơ/gan) và có thể chuyển hóa thành glucose.

Cạn kiệt Glycogen: Thiếu glycogen trong cơ thể thường dẫn đến mất năng lượng và cực kỳ mệt mỏi.

Glycolysis: Chuyển hóa glucose

Cơ quan Golgi Tendon (GTO): GTO là một thụ thể thần kinh nằm ở điểm nối của cơ và gân. Trong quá trình căng cơ, GTO cảm nhận được độ căng của cơ/gân và gửi tín hiệu đến tủy sống. Tủy sống sau đó sẽ gửi tín hiệu trở lại cơ để thư giãn. Đây được gọi là Phản xạ gân Golgi. Nói cách khác, GTO tồn tại để điều chỉnh mức độ căng trên cơ hoặc các cơ để chấn thương không xảy ra với (các) cơ và mô liên kết.

Goniometer: Một công cụ đo lường để đánh giá các góc của cơ thể.

Greater Trochanter: Phần nhô ra ở đầu xương đùi

Tiếp thị du kích: Một hình thức tiếp thị kinh doanh thường rất có tác động và miễn phí hoặc chi phí rất thấp.

Thước dây Gulick: Một loại thước dây đặc biệt dùng để đo chu vi cơ thể. Băng có kết hợp với một lò xo giãn nở để băng không thể bị siết quá chặt. Việc thắt chặt quá mức như vậy sẽ dẫn đến kết quả đo chu vi thực tế nhỏ hơn.

Half-Marathon: Nội dung chạy/cuộc đua (khoảng cách 23,1 dặm)

Hamstrings: Hamstrings bao gồm ba cơ:

- bắp tay nữ
- bệnh bán gân
- bán màng

Các cơ này được sử dụng để ổn định LPHC, uốn cong cẳng chân và duỗi (phía sau) xương đùi

Bảng câu hỏi về lịch sử sức khỏe (HHQ): Cho phép huấn luyện viên có được thông tin cơ bản về khách hàng của họ có liên quan đến quá trình rèn luyện thể chất.

Máy theo dõi nhịp tim (HRM): Thường được đeo như một chiếc đồng hồ, HRM sẽ đọc nhịp tim của một cá nhân theo thời gian thực.

Thoát vị đĩa đệm: Xảy ra khi đĩa đệm bị căng quá mức khiến vòng xơ bị nứt và một số nhân đĩa bị rò rỉ ra ngoài.

Tập luyện cường độ cao không liên tục (HIIT): Đặc trưng bởi mức cường độ bằng hoặc lớn hơn cường độ tập ngắt quãng. Mặc dù khung thời gian cho các đợt tập cường độ/hồi phục có thể gần với khung thời gian tập, HIIT thường kết hợp các phương thức tập luyện khác nhau (ví dụ: Chèo thuyền, rèn luyện sức mạnh, plyometrics, v.v.)

Các cơ khép hông: Có năm cơ chính chịu trách nhiệm cho việc khép hông.

- Pectineus
- Phụ gia Longus
- Gracilis
- Bộ dẫn điện Magnus
- Phụ gia Brevis

Cơ gấp hông: Cơ giúp uốn cong hông. Các cơ gấp hông chính là cơ psoas (chính và phụ) và cơ chậu thường được gọi là nhóm cơ được gọi là iliopsoas. Cơ thắt lưng lớn hoặc cơ thắt lưng cũng khép hông.

Hyperoxic: Liên quan đến tập luyện, điều này đề cập đến việc tập thể dục với lượng oxy bổ sung để một cá nhân hít thở không khí có nồng độ oxy cao hơn mức môi trường cho phép.

Tăng sản: Tăng số lượng tế bào

Phì đại: Xét về mặt phát triển cơ bắp, phì đại là sự gia tăng kích thước của các tế bào cơ, do đó làm tăng kích thước của cơ.

Hạ natri máu: Một tình trạng trao đổi chất trong đó không có đủ natri (tức là mất cân bằng điện giải) trong chất dịch cơ thể. Đây thường là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hydrat hóa quá mức.

Hạ thân nhiệt: Tình trạng nhiệt độ cốt lõi của cơ thể giảm xuống dưới mức cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Điều này xảy ra khi cơ thể mất nhiệt nhanh hơn mức có thể tạo ra nhiệt. Có thể dẫn đến tử vong.

Thiếu oxy: Liên quan đến việc tập luyện, điều này đề cập đến việc tập luyện trong môi trường có lượng oxy giảm. Điều này có thể được thực hiện một cách tự nhiên (huấn luyện ở độ cao) hoặc nhân tạo (buồng cao độ). Mục tiêu của việc luyện tập thiếu oxy là tăng lượng hồng cầu của một người.

Mào chậu: Khía cạnh cao nhất của xương chậu (Ilium)

Iliopsoas: Một nhóm cơ thường được gọi là cơ gấp hông do vai trò chính của chúng. Cơ iliopsoas bao gồm ba cơ: Psoas (chính/phụ), Iliacus.

Hội chứng dây chằng chậu chày (IT): Tình trạng này thường gây đau ở mặt bên của đầu gối. Nguyên nhân chính là do Dây IT cọ xát nhiều lần vào móm lồi cầu ngoài (phần nhô ra ở gốc xương đùi) đến mức xảy ra hiện tượng viêm và đau.

Ilium: Nằm ở hai bên xương cùng, xương chậu là xương lớn nhất trong xương chậu. Mục đích chính của Ilium là bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Huấn luyện viên đạp xe kháng lực trong nhà: Thường được gọi là huấn luyện viên, đây là bộ phận gắn vào bánh sau của xe đạp. Bộ phận này cung cấp lực cản để cho phép một cá nhân tái tạo việc đạp xe ngoài trời.

Kém hơn: Dùng để mô tả hướng giải phẫu, "bên dưới" hoặc "thấp hơn". Một ví dụ về điều này là hông kém hơn ngực.

Các cơ lõi của bộ phận bên trong: Cung cấp sự ổn định và độ cứng cho cột sống và vùng xương chậu. Được tạo thành từ Đa cơ, Cơ bụng ngang, Cơ hoành, Cơ xiên trong và Cơ sàn chậu.

Dây thần kinh: Để cung cấp dây thần kinh cho một khu vực (bộ phận cơ thể). Để kích thích.

Cơ xiên trong: Cơ này có thể được coi là cơ trung gian của lõi xét về vị trí của nó, vì nó nằm giữa cơ bụng ngang và cơ xiên ngoài. Ngoài việc cung cấp sự ổn định cho cột sống, nó còn có hai chức năng bổ sung. Đầu tiên, sự co/thư giãn của cơ xiên trong dẫn đến chuyển động của cơ hoành, cơ hoành chịu trách nhiệm cho việc hít vào và thở ra. Thứ hai, cơ xiên trong chịu trách nhiệm xoay và uốn cong sang bên (uốn cong từ bên này sang bên kia) của phần thân trên.

Các khoảng thời gian: Một phương pháp tập luyện được đặc trưng bởi các khoảng thời gian tập luyện cường độ cao có cấu trúc, sau đó là các giai đoạn phục hồi.

Đĩa đệm: Những đĩa đệm này nằm ở giữa các đốt sống cột sống và được tạo thành từ sụn sợi. Chúng cho phép cột sống di chuyển và hấp thụ lực nén.

Đảo ngược: Xoay vào trong. Khi lòng bàn chân hướng vào trong thì bàn chân bị đảo ngược.

Co cơ không tự nguyện: Kiểu co cơ này được điều khiển bởi hệ thống thần kinh tự trị (ANS) và xảy ra mà không cần suy nghĩ có ý thức. Một ví dụ về điều này là sự co bóp của trái tim.

Cùng bên: Cùng phía với cấu trúc khác. Nâng cánh tay phải là cùng bên với chân phải.

Isokinetic: Co cơ trong đó việc rút ngắn/kéo dài cơ xảy ra ở một tốc độ đã đặt. Tốc độ rút ngắn/kéo dài cơ thường được kiểm soát bởi một nguồn bên ngoài.

Isometric: Loại co cơ đặc trưng bởi sự thiếu chuyển động. Do đó chiều dài cơ vẫn giữ nguyên nhưng có lực căng. Giữ một quả tạ 15 lb. bằng khuỷu tay ở góc 90 độ là một ví dụ về động tác co đẳng cự.

Đẳng trương: Loại co cơ đặc trưng bởi sự rút ngắn cơ khi chịu một tải trọng không đổi tác dụng lên nó. Cơ bắp tay thực hiện động tác uốn cong giữ vật nặng 15 lb. là một ví dụ về co đẳng trương.

Dải chậu chày (IT): Một dải sợi dài bắt nguồn từ mào chậu của xương chậu và gắn vào lồi cầu ngoài của xương chày. Nó chịu trách nhiệm ổn định đầu gối. Cơ mông lớn và cơ tensor latae chèn vào dải IT.

Kinematics: Mô tả sự xuất hiện của chuyển động

Kinesiology: Nghiên cứu về chuyển động của con người

Liên kết động học: Liên quan đến thứ tự các cơ kích hoạt và phối hợp với nhau để cho phép cơ thể di chuyển. Từ quan điểm dựa trên hiệu suất, nó cũng liên quan đến cách cơ bắp hoạt động để mang lại cho một cá nhân lợi thế về cơ sinh học. Còn được gọi là Chuỗi động học.

Động học: Nghiên cứu các lực liên quan đến chuyển động

Chu trình Krebs: Một chu trình gồm các phản ứng hóa học phức tạp mà tế bào trải qua với sự có mặt của oxy để tạo ra năng lượng (hô hấp tế bào).

Kyphosis: Cột sống ngực bị cong quá mức (tăng gấp)

Labrum: Được tìm thấy xung quanh mép khớp vai và khớp hông. Mục đích chính của nó là giữ cho mặt bóng của xương cánh tay và xương đùi tương ứng nằm trong ổ khớp vai và hông. Nó bao gồm sụn sợi.

Chấn thương ở môi âm hộ được gọi là Rách Labral.

Lactate: Một loại enzyme có trong mô cơ thể. Trong những nỗ lực cường độ cao khi nguồn cung cấp oxy bị hạn chế, pyruvate tạo ra lactate cho phép phân hủy glucose để tạo năng lượng. Lactate cũng giúp làm giảm tình trạng nhiễm toan tế bào.

Độ thanh thải Lactate: Quá trình cơ thể sử dụng lactate. Lactate được "làm sạch" theo một trong hai cách:

- Lactate có thể được làm sạch (tức là được sử dụng) một cách oxy hóa trong tế bào cơ nơi nó được sản xuất hoặc nó có thể được vận chuyển đến các tế bào cơ khác để được làm sạch.
- Lactate không bị oxy hóa có thể được loại bỏ yếm khí thông qua Chu trình Cori. Điều này xảy ra ở gan.

Ngưỡng Lactate: Biểu thị mức độ lactate trong máu bắt đầu tích tụ trong dòng máu. Điều này xảy ra tại thời điểm mà tốc độ sản xuất lactate tăng nhanh hơn tốc độ loại bỏ (thanh thải).

Bên: Thuật ngữ định hướng giải phẫu đề cập đến việc di chuyển ra khỏi cơ thể.

Môi lồi xương đùi bên: Một khía cạnh nhỏ, bên, nhô ra ở mặt dưới của xương đùi. Thường được dùng làm điểm mốc, nó nằm ở phía ngoài đầu gối. Cột mốc này thường được cho là nguyên nhân chính gây ra cơn đau do Hội chứng dây chằng chậu chày (Hội chứng dây đeo IT), vì mỏm lồi cầu cọ xát vào Dây đeo IT khi chạy và đạp xe.

Xoay bên (xoay ngoài): Xoay ra xa đường giữa cơ thể. Người bị "chân vòng kiềng" có hiện tượng xoay sang bên của chân trên (xương đùi).

Latissimus Dorsi: Thường được gọi là "lats", cơ latissimus dorsi là cơ lớn nhất ở lưng. Chức năng chính của nó là khép cánh tay, xoay vào trong xương cánh tay và xoay xương bả vai xuống dưới. Nó cũng hỗ trợ ổn định LPHC.

Trục vĩ độ: Trục dọc (thường được gọi là trục "Y"). Xoay người bằng một chân khi đứng tượng trưng cho sự quay quanh trục vĩ độ.

Chênh lệch chiều dài chân (LLD): Một chân dài hơn chân kia. Có hai cách phân loại về sự khác biệt về chiều dài chân. LLD chức năng có nghĩa là một chân có vẻ dài hơn chân kia do chấn thương hoặc mất cân bằng cơ khiến hông bị nghiêng. LLD thực tế có nghĩa là về mặt cấu trúc, một chân dài hơn chân kia.

Mối quan hệ giữa độ dài/độ căng: Nếu cơ bị rút ngắn hoặc kéo dài quá nhiều, lực sinh ra của cơ sẽ giảm đến mức có thể tạo ra lực ở mức tối thiểu hoặc không thể tạo ra lực. Mối quan hệ giữa chiều dài của cơ và khả năng tạo ra lực là đường cong hình chuông.

Cơ nâng xương vai: Hỗ trợ mở rộng cổ tử cung. Cơ này nằm ở đáy và phía sau cổ.

Dây chằng: Một mô sợi nối xương với xương.

Cơ dài: Cơ quá dài (tức là bị kéo căng) để tạo ra đủ lực. Điều này thường được gọi là cơ bị ức chế.

Khoảng cách ổn định dài (LSD): Một loại hình tập luyện thể thao sức bền tương ứng với việc tập luyện trên một quãng đường dài và với tốc độ ổn định, tương đối dễ đến vừa phải.

Độ cong lưng: Độ cong cột sống thất lưng/cổ quá mức (tăng huyết áp)

Cột sống thất lưng: Thường được gọi là thất lưng, cột sống thất lưng bao gồm 5 đốt sống (L1-L5) và nằm giữa mặt ngực của cột sống và xương cụt.

Phức hợp thất lưng-xương chậu-hông (LPHC): Thường được gọi là Lõi. LPHC đặc biệt giải quyết khu vực ổn định phần trên và phần dưới cơ thể. Do đó, các cơ hoạt động để ổn định phức hợp này có thể được xem là cơ lõi.

Marathon: Sự kiện chạy/cuộc đua (khoảng cách 26,2 dặm)

Trạng thái ổn định Lactate tối đa (MLSS): Mức cường độ cao nhất mà nồng độ lactate trong máu được duy trì ở mức trạng thái ổn định (cân bằng) trong các buổi tập luyện khoảng 60 phút.

Trung gian: Thuật ngữ định hướng giải phẫu liên quan đến việc ở gần đường giữa của cơ thể hơn.

Xoay trong (xoay trong): Xoay về phía đường giữa của cơ thể. Người bị "gập đầu gối" có xoay trung gian của chân trên (xương đùi).

Bóng thuốc: Một quả bóng tròn có nhiều trọng lượng và kích cỡ khác nhau và được sử dụng cho mục đích tăng cường sức mạnh và dưỡng chất.

Hình ảnh tinh thần: Một kỹ thuật được các vận động viên sử dụng để nâng cao thành tích. Hình ảnh bên ngoài xảy ra khi một cá nhân "nhìn thấy" mình đang thực hiện một hoạt động với mục tiêu hình dung ra hoạt động được thực hiện một cách hoàn hảo. Hình ảnh bên trong xảy ra khi một cá nhân "cảm nhận" cách họ dự đoán cảm giác trong sự kiện để chuẩn bị cho sự kiện đó. Hình ảnh bên trong cũng có thể liên quan đến việc hình dung từ góc nhìn của người thứ nhất.

Midtarsal (còn gọi là Transverse Tarsal và Talocalcaneonavicular): Khớp này trải dài qua vòm bàn chân và chủ yếu kiểm soát sự đảo ngược và lật ngược của bàn chân. Khớp này dao động từ linh hoạt đến cứng nhắc tùy thuộc vào khía cạnh nào của giai đoạn hỗ trợ và dẫn động của bàn chân. Khi chạy hoặc đi bộ, khi bàn chân di chuyển dưới trọng tâm của cơ thể và chuẩn bị đẩy ra, khớp sẽ khóa và trở nên cứng để tạo ra một cơ sở hỗ trợ ổn định để đẩy ra.

Giày chạy bộ tối giản: Loại giày có phần đệm gót chân/hỗ trợ vòm tối thiểu và thường được thiết kế để có trọng lượng nhẹ. Điều này thường dẫn đến độ tụt thấp từ gót chân đến ngón chân. Giày tối giản thường được thiết kế để chạy với tư thế tiếp đất ở giữa bàn chân.

Ti thể: Một bào quan là nhà máy năng lượng của tế bào. Chuyển đổi thể năng từ các phân tử thức ăn thành ATP.

Đơn vị vận động: Một tế bào thần kinh vận động và tất cả các sợi cơ mà nó chi phối.

Multifidus: Multifidus (mull-tiff-a-duss) thực chất là một chuỗi các cơ nhỏ bám theo hai bên của cột sống và nằm sâu trong cơ dựng cứng cột sống. Multifidus có thể được chia thành các cơ nông và sâu. Multifidus nông chịu trách nhiệm cho việc duỗi lưng thất lưng, xoay và uốn cong sang bên và multifidus sâu chịu trách nhiệm ổn định cột sống. Multifidus phối hợp với TVA để mang lại sự ổn định cho cột sống.

Chuột rút cơ: Đặc trưng bởi tình trạng cơ co thắt không chủ ý (tức là co thắt) thường gây đau do cường độ và thời gian co bóp. Chuột rút thường do cạn kiệt glycogen, mất nước, nồng độ kali thấp, tập thể dục trong thời gian dài hơn hoặc ở cường độ cao hơn mức bình thường của cơ thể.

Mất cân bằng cơ: Xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa hai cơ đối lập bao quanh khớp. Sự mất cân bằng cơ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm các cử động theo thói quen và lặp đi lặp lại, tư thế không đúng, cơ bị hạn chế, chấn thương hoặc phẫu thuật.

Trực cơ: Trực cơ nằm sâu trong bụng cơ. Các trực cơ cảm nhận được sự thay đổi về chiều dài cơ cũng

như phạm vi thay đổi về chiều dài và gửi tín hiệu đến cột sống. Tín hiệu này kích hoạt phản xạ căng cơ (còn gọi là: phản xạ cơ). Phản xạ căng có vẻ chống lại sự gia tăng chiều dài cơ bằng cách khiến cơ co lại. Chiều dài cơ tăng càng nhanh thì phản xạ căng càng mạnh. Vì vậy, chức năng chính của thoi cơ là bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương do căng quá mức.

Bong gân cơ: Chấn thương dây chằng (dây chằng nối xương với xương). Bong gân được phân loại từ Cấp độ 1-3 với cấp độ 3 là nghiêm trọng nhất

Căng cơ: Chấn thương cơ hoặc gân (gân nối xương với cơ)

Bù trừ cơ bắp: Xảy ra khi cơ không thể cung cấp một số hoặc tất cả hoạt động kích hoạt cơ cần thiết. Điều này dẫn đến việc các cơ khác được kích hoạt để hỗ trợ thực hiện một chức năng của cơ thể (tức là chuyển động của một bộ phận cơ thể).

Giải phóng cân cơ: Liên quan đến việc giảm độ căng và hạn chế của các cơ và cân.

Myofibril: Các sợi cơ chạy dọc theo chiều dài của sợi cơ

Myostatin: Protein quyết định kích thước của cơ

Phân chia tiêu cực: Đề cập đến chiến lược tập luyện hoặc đua xe có cấu trúc trong đó một cá nhân chạy nửa sau của sự kiện hoặc buổi tập luyện với tốc độ nhanh hơn nửa đầu. Phân chia tiêu cực cũng có thể đề cập đến việc thực hiện Lặp lại, với mỗi nỗ lực được thực hiện với tốc độ nhanh hơn nỗ lực trước đó.

Tác động lên dây thần kinh: Thường được gọi là Dây thần kinh bị chèn ép. Xảy ra khi một dây thần kinh có áp lực lên nó. Áp lực này thường dẫn đến đau, tê hoặc yếu cơ ở vùng mà (các) dây thần kinh chi phối.

Phản ứng thần kinh nội tiết: Liên quan đến sự tương tác giữa hệ thống thần kinh và nội tiết xảy ra với cơ thể khi thực hiện các loại động tác rèn luyện sức mạnh cụ thể. Phản ứng thần kinh nội tiết cao nhất xảy ra khi thực hiện các bài tập huy động khối lượng cơ lớn và được thực hiện với khối lượng lớn với sức đề kháng từ trung bình đến cao. Phản ứng này làm tăng testosterone và hormone (tức là hormone tăng trưởng) kích thích tăng trưởng/sức mạnh cơ bắp.

Cột sống trung tính: Vị trí cột sống yêu cầu hoạt động thần kinh cơ tối thiểu để duy trì tư thế thư giãn ở tư thế đứng.

Bắt đầu tích lũy Lactate trong máu (OBLA): Xảy ra khi nồng độ lactate trong máu đạt 4 milimol trên lít (mmol/L) trong các buổi tập luyện.

Bài tập chuỗi mở: Bài tập trong đó tay hoặc chân có thể tự do di chuyển trong không khí.

Cơ bắp lõi đơn vị bên ngoài: Mục đích chính của cơ lõi bên ngoài là tạo ra chuyển động và mục đích phụ của nó là hỗ trợ cung cấp sự ổn định cho LPHC. Bao gồm Cơ thẳng bụng, cơ xiên ngoài bụng, cơ dựng cơ đùi, cơ tứ đầu thắt lưng, cơ iliopsoas, cơ khớp hông, cơ gân kheo, cơ thẳng đùi, cơ mông Maximus.

Tập luyện quá sức: Kết quả của việc tập luyện quá nhiều mà không được nghỉ ngơi hợp lý. Kết quả là cá nhân không thể phục hồi bình thường và do đó hiệu suất giảm sút và trong một số trường hợp có thể dẫn đến chấn thương.

Màn hình squat trên cao (OSS): Một trong những bài kiểm tra chức năng toàn diện tốt nhất để đánh giá sức mạnh, tính linh hoạt và hiệu quả thần kinh cơ. Bài kiểm tra được thực hiện bằng cách yêu cầu một

cá nhân ngồi xổm xuống với trọng lượng dồn lên gót chân và cánh tay qua đầu. Hình thức được đánh giá về độ lệch tư thế.

Nguyên tắc quá tải: Cơ thể cần phải có áp lực lớn hơn bình thường để quá trình thích nghi tập luyện diễn ra.

Huấn luyện từ xa: Tập luyện với quãng đường dài hơn quãng đường đua thực tế

Phát âm quá mức (mất cá chân): Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về việc chính xác bao nhiêu độ tương đương với phát âm quá mức, nhiều bác sĩ lâm sàng tin rằng góc khớp dưới sên lớn hơn 8-10 độ tương đương với phát âm quá mức.

Quá trình Phosphoryl hóa oxy hóa: Một con đường trao đổi chất bao gồm một loạt các phản ứng hóa học trong tế bào và là giai đoạn cuối cùng của con đường hiếu khí. Giai đoạn này chịu trách nhiệm cho phần lớn việc tạo ra ATP.

Nợ oxy: Sự khác biệt giữa mức tiêu thụ oxy khi nghỉ ngơi và tốc độ tiêu thụ oxy tăng cao sau một buổi tập luyện.

Nhịp độ: Liên quan đến một kế hoạch có cấu trúc về cường độ và/hoặc tốc độ trong suốt buổi tập luyện hoặc cuộc đua. Kế hoạch này là một phần của chiến lược tổng thể cho một buổi tập luyện hoặc cuộc đua.

Hội chứng xương bánh chè (PFS): Đặc trưng bởi cơn đau phía sau xương bánh chè. Thường được gọi là Đau gối của người chạy bộ. Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn gây ra PFS bao gồm mất cân bằng cơ của cơ tứ đầu, xoay hông không đối xứng và lực nén.

Đỉnh cao: Một quy trình có hệ thống trong đó một cá nhân nhận ra mức độ chuẩn bị thể chất cao nhất có thể của họ vào một ngày hoặc khung thời gian nhất định.

Pectoralis Major: Cơ chính của ngực. Nó là một cơ hình quạt có nguồn gốc từ xương ức và bám vào xương cánh tay. Động tác chính là gấp, khép và xoay xương cánh tay vào trong.

Ngực nhỏ: Cơ ngực sâu. Có tác dụng di chuyển xương bả vai về phía trước và xuống dưới.

Xương chậu: Thường được gọi là hông, xương chậu ngăn cách phần thân dưới với thân. Do vị trí của nó trong hệ thống xương, chuyển động của xương chậu ảnh hưởng đến cả phần trên và phần dưới cơ thể. Từ góc độ bộ xương, xương chậu tượng trưng cho phần đáy của cột sống cũng như vị trí mà xương đùi chèn vào.

Cơ sàn chậu (PF): Bao gồm Cơ nâng cơ, Coccygeus và mô liên kết, các cơ sàn chậu về cơ bản tạo thành một "chiếc võng" hỗ trợ các cơ quan vùng chậu (tức là bàng quang). Các cơ PF hỗ trợ ổn định cột sống và xương chậu.

Đánh giá cường độ cảm nhận (PIA): Được phát triển bởi UESCA, nó được sử dụng để đánh giá ngưỡng cường độ của khách hàng. PIA sử dụng bài tập ngồi trên tường để kiểm tra ngưỡng cường độ của một người.

Chu kỳ định kỳ: Thể hiện cách cấu trúc một mùa đào tạo. Các chu kỳ định kỳ là: Macro, Meso và Micro. Macrocycle đại diện cho năm. Mesocycle đại diện cho một khối thời gian (được biểu thị bằng một số microcycle), thường là từ 2-6 microcycle. Chiếc xe vi mô được biểu thị bằng một tuần.

Peroneals: Các cơ này nằm ở mặt bên của cẳng chân. Được tạo thành từ Longus Peroneous, Brevis

Peroneous. Chúng kiểm soát độ gấp lòng bàn chân và độ lật của bàn chân.

Bảng câu hỏi về mức độ sẵn sàng cho hoạt động thể chất (PAR-Q): Được sử dụng để xác định xem khách hàng tiềm năng có đủ sức khỏe và an toàn về mặt thể chất để bắt đầu một chương trình tập thể dục hay không. Những cá nhân không vượt qua PAR-Q không thể bắt đầu chương trình tập thể dục mà không có sự cho phép của bác sĩ.

Piriformis: Dạng xương đùi khi hông gấp. Đối với nhiều người, dây thần kinh hông đi qua cơ piriformis. Do đó, khi cơ piriformis thắt chặt, dây thần kinh hông sẽ bị chèn ép và gây ra đau thần kinh tọa (cơn đau bắt nguồn từ cơ mông và thường lan xuống chân qua dây thần kinh tọa). Điều này được gọi là Hội chứng Piriformis.

Viêm cân gan chân: Cân gan chân là một dải xơ chạy từ gót chân đến bàn chân trước. Kích ứng màng cân thường biểu hiện bằng đau gót chân hoặc vòm.

Ghìem lòng bàn chân: Tăng góc giữa cẳng chân và bàn chân. Phụ nữ đi giày cao gót thường xuyên ở trạng thái gấp bàn chân.

Plyometrics: Một kỹ thuật tập luyện xây dựng sức mạnh được đặc trưng bởi các chuyển động bùng nổ.

Popliteus: Đây là một cơ nhỏ nằm phía sau đầu gối. Hành động chính là uốn cong đầu gối và cụ thể hơn là nó có nhiệm vụ "mở khóa" đầu gối từ tư thế duỗi thẳng. Nó cũng hỗ trợ xoay trong xương chày. Bàn chân nghiêng quá mức hoặc đầu gối duỗi quá mức khi chạy có thể làm tổn thương cơ khoeo. Chấn thương này thường gây khó khăn và/hoặc đau khi duỗi đầu gối.

Sau: Thuật ngữ định hướng giải phẫu đề cập đến phía sau hoặc phía sau cơ thể.

Công suất: Tốc độ thực hiện công việc. Phương trình của công suất là: $P = W/T$ (P = công suất, W = công và T = thời gian).

Động lực chính: Một cơ hoặc nhóm cơ chịu trách nhiệm chính tạo ra chuyển động.

Phát âm: Xoay trong của một bộ phận cơ thể.

Nằm sấp: Vị trí giải phẫu trong đó mặt trước hướng xuống dưới. Nằm úp mặt là một ví dụ về cơ thể ở tư thế nằm sấp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thần kinh cơ nhận cảm (PNF): Kéo dài PNF bao gồm kéo giãn thụ động, sau đó là co cơ đẳng cự. Trong quá trình kéo giãn PNF, cơ liên tục co lại và giãn ra, điều này kích hoạt phản xạ gân golgi nhiều lần.

Protein: Một phân tử bao gồm một hoặc nhiều chuỗi axit amin. Protein cần thiết cho cấu trúc, chức năng và sự điều hòa của tế bào, mô và cơ quan của cơ thể.

Kéo dài: Di chuyển về phía trước (về phía trước). Đôi vai tròn về phía trước cơ thể ở trạng thái kéo dài.

Gần: Điểm gần, gần tâm cơ thể hơn. Xương đùi nằm gần xương chày.

Giao hưởng xương mu: Kết nối hai bên của xương chậu dưới (ischium). Khớp này là khớp bán động và được kết nối bằng dây chằng và sụn. Bắp giao hưởng xương mu mở rộng khi khoảng cách giữa hai chân mở rộng. Đau ở khớp mu có thể xảy ra khi khớp không trở lại vị trí bình thường (tức là bị lệch).

Tuần hoàn phổi: Hệ thống này liên quan đến tim và phổi. Máu bị khử oxy rời khỏi tim và đi đến phổi, nơi nó được tái oxy hóa và quay trở lại tim.

Pyruvate: Một loại axit được tạo ra từ quá trình đường phân.

Q-Góc: Góc giữa hai đường: Đường 1-ASIS đến Xương bánh chè, Đường 2-Ốc xương chày đến Xương bánh chè

Quadratus Lumborum: Bắt nguồn từ mào chậu và bám vào xương sườn thấp nhất và bên cạnh đốt sống thắt lưng. Có tác dụng ổn định xương chậu và uốn cong cột sống thắt lưng sang một bên.

Cơ tứ đầu: Nhóm cơ này thường được gọi là "cơ tứ đầu", được tạo thành từ bốn cơ khác nhau và nằm ở phía trước của bắp chân: Vastus Lateralis, Vastus Medialis, Vastus Intermedius, Rectus Femoris. Những cơ này được sử dụng để mở rộng cẳng chân và ổn định đầu gối. Cơ thẳng đùi cũng có tác dụng uốn cong hông.

Bệnh rễ thần kinh: Đau các chi (cánh tay, bàn tay, thức ăn) bắt nguồn từ việc dây thần kinh cột sống bị chèn ép.

Thang đo tỷ lệ gắng sức nhận thức (RPE): Một bài kiểm tra chủ quan đo lường mức độ gắng sức hoặc đau đớn về thể chất.

R.I.C.E: Từ viết tắt của Rest-Ice-Compression-Elevation. Mục đích của R.I.C.E. là sơ cứu các vết thương ở mô mềm và được sử dụng để giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm và tăng sự thoải mái cho cá nhân.

Nhịp tim phục hồi: Đánh giá nhịp tim giảm nhanh như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định sau một nỗ lực mãnh liệt. Khi một vận động viên trở nên khỏe mạnh hơn, nhịp tim sẽ hồi phục nhanh hơn.

Trực bụng: Cơ này được tạo thành từ hai cơ chạy song song với nhau và được ngăn cách bởi mô liên kết (linea alba). Cơ bụng thẳng chịu trách nhiệm chính cho việc uốn cong cột sống thắt lưng. Thứ hai, cơ bụng thẳng hỗ trợ ổn định cột sống thắt lưng thông qua sự co đẳng cự.

Trực tràng đùi: Cơ thẳng đùi là một trong bốn cơ tạo nên cơ tứ đầu và về mặt trực quan là cơ trung tâm của bốn cơ khi xem cơ ở mặt phẳng phía trước. Vai trò chính của cơ thẳng đùi là duỗi đầu gối và gập hông tuy nhiên nó cũng đóng vai trò ổn định LPHC và đầu gối.

Giảm kích hoạt cơ: Xảy ra khi cơ quá căng. Điều này làm cho các xung động của hệ thần kinh tới cơ bắp quá căng giảm đi. Sự giảm này ảnh hưởng đến khả năng co bóp của cơ đối diện (đối kháng).

Lặp lại: Chúng có đặc điểm là chạy với tốc độ nhanh trong một khoảng thời gian (hoặc quãng đường) nhất định, sau đó là giai đoạn phục hồi rồi chạy lại cùng quãng đường và/hoặc tốc độ đó.

Huấn luyện sức đề kháng: Bất kỳ loại bài tập nào gây căng thẳng cho (các) cơ nhằm mục đích tăng sức mạnh. Thường liên quan đến môn thể dục trị liệu hoặc nâng tạ.

Nhịp tim khi nghỉ ngơi: Thể hiện nhịp tim lúc nghỉ ngơi (trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng). Điều này có thể được sử dụng như một đánh giá vì thông thường, cơ thể càng trở nên "trong hình dạng" thì nhịp tim khi nghỉ ngơi càng thấp.

Thu lại: Di chuyển lùi (về phía sau). Siết chặt hai bả vai lại với nhau sẽ dẫn đến hiện tượng rút lại các bả vai.

Xương sườn: Xương dài và cong giúp bảo vệ các cơ quan nội tạng. Con người có 24 xương sườn (12 cặp)

Hình thoi: Chức năng chính của hình thoi là ổn định, xoay và rút xương bả vai. Nguồn gốc của hình thoi

là cột sống và chúng bám vào mặt trong của xương bả vai.

Quay: Chuyển động tròn quanh một điểm cố định. Xoay thân trong mặt phẳng ngang khi ở tư thế đứng thẳng là một ví dụ về xoay.

Rotator Cuff: Các cơ và gân liên quan giúp kiểm soát chuyển động và ổn định khớp vai. Bao gồm các cơ sau và hoạt động tương ứng của chúng:

- Supraspinatus: Bắt cóc vai
- Cơ sở dưới gai: Xoay vai ngoài
- Teres Minor: Xoay vai ngoài
- Subscapularis: Xoay vai bên trong

Khớp cùng chậu (Khớp SI): Khớp SI là phần kết nối giữa xương cùng và xương chậu, nằm ở hai bên cột sống. Khớp SI được ổn định nhờ dây chằng chắc chắn. Mục đích của khớp là hấp thụ sốc của cột sống. Các khớp khóa khi đi và chạy để cung cấp chỗ dựa vững chắc trong quá trình đẩy chân ra khỏi đất đi.

Xương cùng: Vị trí nối cột sống thất lưng với xương cụt. Được tạo thành từ năm đốt sống hợp nhất.

Mặt phẳng Sagittal: Chia cơ thể thành hai nửa bên phải và bên trái. Đi theo đường thẳng (tiền hoặc lùi) thể hiện chuyển động trong mặt phẳng dọc.

Sarcomere: Một đơn vị trong sợi cơ chịu trách nhiệm co cơ. Về bản chất, nó là đơn vị chức năng của tế bào cơ.

Sartorius: Đây là cơ dài nhất trong cơ thể và bắt đầu (xuất phát) bên dưới ASIS và kết thúc (chèn) ở mặt trên và mặt trong của xương chày. Cơ này có tác dụng uốn cong, dạng và xoay hông ra ngoài. Nó cũng hỗ trợ việc uốn cong đầu gối.

Scapula: Thường được gọi là xương vai, nó nối xương cánh tay và xương đòn.

Đau thần kinh tọa: Đau xuống mặt sau và mặt bên của chân. Đây là một thuật ngữ chung hơn là một điều kiện cụ thể. Đau thần kinh tọa có thể biểu hiện dưới dạng nén (tức là thoát vị đĩa đệm), trượt đốt sống hoặc co cơ.

Vẹo cột sống: Độ cong cột sống ở mặt phẳng trán (độ cong bên). Có hai cách phân loại chứng vẹo cột sống: Cấu trúc và Chức năng. Nguồn gốc của chứng vẹo cột sống chức năng bắt nguồn từ những nơi khác trong cơ thể, chẳng hạn như sự chênh lệch về chiều dài chân trong khi chứng vẹo cột sống cấu trúc bắt nguồn từ sự phát triển bất thường ở cột sống. Vẹo cột sống cấu trúc thường biểu hiện bằng sự xoay hoặc xoắn cột sống cũng như độ cong bên. Dấu hiệu rõ ràng của chứng vẹo cột sống là hông và vai không đều nhau.

Động lực phụ ("bộ ổn định"): Một cơ hoặc nhóm cơ góp phần gián tiếp vào việc tạo ra chuyển động. Động cơ phụ hỗ trợ động cơ chính. Ví dụ, trong quá trình chống đẩy, cơ ngực chính là cơ vận động chính và cơ tam đầu là cơ vận động phụ.

Máy tập sức mạnh chọn lọc: Một loại máy tập sức đề kháng thường tập trung vào một hoặc hai cơ. Đặc trưng bởi người dùng có thể chọn trọng lượng thích hợp bằng cách chèn một "chốt" vào một chồng trọng lượng.

Serratus Anterior: Bắt nguồn từ các xương sườn và gắn vào mặt trong của xương bả vai. Chức năng

của nó là kéo dài, ổn định và xoay xương bả vai lên trên. Cơ này thường được gọi là "cơ võ sĩ quyền anh" vì nó kéo xương bả vai về phía trước, giống như khi tung một cú đấm.

Lực cắt: Lực song song với bề mặt.

Shin Spint: Một thuật ngữ tương đối chung dùng để mô tả cơn đau ở vùng xương chày. Nẹp Shin có thể được phân loại thành ba khu vực chính: Cơ bắp, cân xương chày và xương. Nếu khách hàng của bạn bị đau ống chân, bạn nên nhờ họ tìm tư vấn y tế vì loại phương pháp điều trị có thể sẽ khác nhau tùy theo "loại" gai ống chân.

Cơ ngắn: Cơ không đủ dài (tức là căng) để tạo ra đủ lực.

Sàng lọc khả năng vận động của vai (SMS): Đánh giá nhằm đánh giá phạm vi chuyển động của vai, chủ yếu là các cơ và mô liên kết liên quan đến chuyển động xoay trong và ngoài.

Nút xoang nhĩ (Nút SA): Máy điều hòa nhịp tim tự nhiên của tim. Nút SA gửi tín hiệu điện qua tim gây co bóp.

Cơ xương: Tất cả các cơ không phải là cơ tim hoặc cơ trơn. Đây là những cơ cung cấp sự chuyển động của cơ thể và chiếm 35-45% trọng lượng cơ thể con người. Có khoảng 640 cơ xương trong cơ thể, hầu hết chúng được nhóm thành từng cặp.

Thước đo nếp gấp da: Một công cụ đánh giá dùng để kẹp mỡ dưới da ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể đối tượng nhằm mục đích xác định thành phần cơ thể của họ.

Mô hình sợi trượt: Mô hình này cho biết rằng trong sarcomere, Actin và myosin lần lượt được xếp chồng lên nhau. Myosin "bánh cóc" dọc theo Actin và làm cho Actin bị rút ngắn lại. Sự nén này làm cho sarcomere ngắn lại. Mỗi sarcomere được kết nối với sarcomere tiếp theo bằng cái gọi là "đường Z" - hay đĩa Z. Khi một cơ co lại, tất cả các sarcomer đều co lại cùng một lúc. Sự co đồng thời này tạo ra lực ở mỗi đầu sợi cơ.

Sợi cơ co giật chậm (ST): Thường được gọi là sợi cơ "Loại 1". Đặc trưng bởi khả năng co bóp liên tục trong thời gian dài nhưng với lực tương đối thấp. Sợi ST dựa vào oxy để tạo năng lượng và do đó có màu đỏ do có nhiều mạch máu.

Cơ trơn: Các cơ không tự chủ bao quanh các cơ quan nhằm mục đích bảo vệ khỏi các lực bên ngoài

Đế: Cơ sâu, nằm phía sau xương chày và bên dưới cơ bụng. Có tác dụng uốn cong và ổn định lòng bàn chân cũng như mắt cá chân.

Hẹp ống sống: Thu hẹp ống sống do thoái hóa, mất ổn định hoặc do tổn thương. Ống sống là một lỗ thẳng đứng bên trong đốt sống cho phép tủy sống đi qua.

Spin Bike: Xe đạp trong nhà có đặc điểm là chỉ có một tốc độ và bánh đà nặng. Thường được sử dụng trong hình thức lớp học nhóm.

Cột sống: Còn được gọi là Đốt sống hoặc Cột sống, cột sống được tạo thành từ 33 đốt sống. Nó được chia thành năm phần: Cổ tử cung, ngực, thắt lưng, xương cùng và xương cụt.

Trượt đốt sống: Một đốt sống bị "trượt" so với đốt sống liền kề. Phổ biến nhất là các đốt sống di chuyển về phía trước tuy nhiên nó có thể di chuyển sang bên và ra sau.

Giãn tĩnh: Kéo giãn khi phần cơ thể được giữ ở tư thế duỗi, không chuyển động.

Sức mạnh: Khả năng của một người tác dụng lực lên một vật bằng hệ thống cơ xương.

Sức mạnh-Sức bền liên tục: Nói rằng sức mạnh và sức bền có mối quan hệ nghịch đảo.

Sải bước: Sải bước về cơ bản là chạy nước rút (không phải nỗ lực 100%) được thực hiện trước và sau khi chạy hoặc cuộc đua. Mục đích của việc thực hiện chúng trước cuộc đua là làm nóng chân để tăng lưu lượng máu cũng như giúp tâm trí thích nghi với tốc độ cuộc đua. Sải bước cũng có tác dụng nâng cao hiệu quả thần kinh cơ của người chạy.

Thể tích đột quy: Lượng máu được bơm từ tim (tâm thất trái) trong một nhịp.

Khớp dưới sên: Nối xương sên và xương vôi. Đây là một khớp trượt và cho phép xảy ra hiện tượng đảo ngược và lật cổ chân. Gân Achilles bao phủ khớp dưới xương sên khi nhìn chân từ phía sau.

Bề ngoài: Thuật ngữ định hướng được sử dụng để mô tả rằng một cấu trúc gần bề mặt cơ thể hơn một cấu trúc khác (tức là Da nằm ở bề mặt của xương)

Cao cấp: Dùng để mô tả vị trí giải phẫu trong đó một móc nằm phía trên một móc khác (về phía đầu). Một ví dụ về điều này là thân tốt hơn chân.

Supination (mắt cá chân): Còn được gọi là "ngón sấp", về cơ bản là thiếu cách quay sấp.

Nằm ngửa: Vị trí giải phẫu trong đó mặt trước hướng lên trên. Nằm ngửa là một ví dụ về tư thế cơ thể nằm ngửa.

Tuần hoàn hệ thống: Hệ thống này liên quan đến tuần hoàn khắp cơ thể ngoại trừ phổi. Máu giàu oxy rời khỏi tim qua các động mạch để cung cấp cho cơ thể và máu đã khử oxy sẽ quay trở lại tim qua các tĩnh mạch.

Khớp Talocrural: Kết nối xương chày và xương mác với xương sên ở bàn chân. Đây là khớp bản lề và cho phép mắt cá chân gập mặt lưng và mặt lòng bàn chân.

Taper: Giảm khối lượng tập luyện và đôi khi là cường độ tập luyện một cách có hệ thống. Thực hiện với mục đích phục hồi và thường được thực hiện trước một sự kiện quan trọng.

Tarsometatarsal: Khớp này cũng trải dài theo chiều rộng của vòm bàn chân. Nằm ở phía sau xương bàn chân, thực sự là ở điểm nối giữa bàn chân giữa và bàn chân trước. Khớp này có độ ổn định cao hơn và phạm vi di chuyển ít hơn so với khớp giữa.

Tốc độ: Các bài tập này thường được thực hiện ở tốc độ ngay dưới tốc độ cuộc đua và được thực hiện trong 5-20 phút (không bao gồm khởi động/hạ nhiệt) mỗi lần, tùy thuộc vào độ dài của sự kiện được tập luyện. Nên khởi động thật nhiều khi thực hiện các nỗ lực về nhịp độ.

Bệnh gân: Thiệt hại về tính toàn vẹn cấu trúc của gân.

Gân: Mô sợi nối xương với cơ.

Tensor Fasciae Latae (TFL): Có tác dụng dạng hông. TFL cũng kéo dài và xoay hông ra bên ngoài. TFL nằm ở bên hông.

Theraball: Bóng bơm hơi hình tròn có nhiều kích cỡ khác nhau. Dùng cho các bài tập.

Theraband: Dây đeo loại cao su thường phẳng và rộng hoặc ở dạng ống và thường có tay cầm gắn ở hai đầu. Được sử dụng cho các bài tập sức đề kháng.

Đào tạo ngưỡng: Mục đích của việc rèn luyện ngưỡng là tăng ngưỡng lactate (LT) của một người. Quá

trình đào tạo này diễn ra trong phạm vi từ thấp hơn đến cao hơn MLSS một chút. Mặc dù việc rèn luyện ngưỡng có thể là những nỗ lực ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng chúng cũng có thể ngắn hơn hoặc có cường độ thay đổi. Đào tạo nhịp độ là một loại đào tạo ngưỡng.

Cột sống ngực: Nằm giữa phần cổ và phần thắt lưng của cột sống. Nó thường được gọi là lưng giữa đến trên. Cột sống ngực bao gồm 12 đốt sống (T1-12).

Xương chày: Xương ở cẳng chân tiếp giáp với xương mác. Kết nối xương đùi và mắt cá chân.

Xương chày trước: Thường được gọi là cơ ống chân. Nó nằm ở phía trước của cẳng chân (xương chày). Hành động này là gập mặt lưng của mắt cá chân.

Xương chày sau: Nằm sâu ở cẳng chân và phía sau xương chày, xương chày sau có tác dụng hỗ trợ và ổn định cẳng chân cũng như uốn cong cổ chân.

Mô-men xoắn: Tác dụng quay của lực

Khối đào tạo: Được phát triển bởi UESCA, các khối đào tạo giúp cung cấp cấu trúc cho chương trình đào tạo hàng năm. Có năm khối đào tạo: Cơ sở, Phát triển, Đỉnh cao, Giảm dần, Không theo mùa.

Nhật ký tập luyện: Bản ghi lại quá trình tập luyện của vận động viên. Thông thường, nhật ký được điền hàng ngày và bao gồm nhiều loại thông tin bao gồm khoảng cách, chỉ số sinh lý (nhịp tim) và mức năng lượng.

Cơ bụng ngang (TVA): Đây là cơ sâu nhất trong tất cả các cơ bụng và tác dụng chính của nó là mang lại sự ổn định cho vùng thắt lưng. TVA hoạt động như đai trọng lượng tự nhiên của cơ thể bằng cách tạo ra lực căng vòng quanh phần giữa của một cá nhân.

Mặt phẳng ngang: Chia cơ thể thành phần trên và dưới hay cụ thể hơn là phần trên và phần dưới. Chuyển động phổ biến nhất trong mặt phẳng ngang là chuyển động quay. Xoay phần thân trên sang một bên là một ví dụ về chuyển động trong mặt phẳng ngang.

Hình thang: Một cơ lớn hình kim cương bao gồm ba phần: Trên, Giữa và Dưới. Tác dụng chính của cơ thang là ổn định, nâng lên, rút lại và xoay xương bả vai lên trên.

Cơ tam đầu Brachii: Nhóm cơ sau của cánh tay trên (xương cánh tay). Duỗi khuỷu tay. Cơ tam đầu bao gồm ba đầu cơ: Bên, trong và dài.

Triglyceride: Hợp chất có chứa glycerol và axit béo tự do. Glycerol là một hợp chất hóa học là cấu trúc hỗ trợ hóa học chính của chất béo trung tính. Glycerol và axit béo tự do là những yếu tố mà cơ thể dị hóa (phân hủy) để lấy năng lượng. Glycerol bị phân hủy kỵ khí thông qua quá trình glycolysis trong khi axit béo được dị hóa thông qua một quá trình gọi là quá trình oxy hóa beta. Trong quá trình oxy hóa beta, axit béo được chuyển đổi thành Acetyl Co-A và sau đó đi vào Chu trình Krebs để bị oxy hóa.

Hai ngày một ngày (TADS): Hai bài tập trong một ngày.

Ultramarathon: Bất kỳ cuộc đua nào vượt cự ly marathon (>26,2 dặm)

Một bên: Liên quan đến chuyển động của một bên cơ thể. Nâng chỉ một cánh tay là một ví dụ về chuyển động đơn phương.

Điền kinh Hoa Kỳ (USATF): Cơ quan quản lý quốc gia về chạy bộ và điền kinh tại Hoa Kỳ

Valgus: Góc vào trong của xương hoặc khớp (ví dụ: Knock Knees).

Varus: Góc ngoài của xương hoặc khớp (ví dụ: Chân vòng kiềng).

Tĩnh mạch: Vận chuyển máu đã khử oxy (không có oxy) đến tim.

Ngưỡng thông khí (VT): Điểm mà tốc độ thông khí tăng nhanh hơn khối lượng công việc. Cho đến khi đạt được VT, khối lượng công việc và nhịp thở tăng tuyến tính.

Đốt sống: Các xương tạo nên cột sống.

VO2 Max: Thường được gọi là mức tiêu thụ oxy tối đa của một cá nhân hoặc là bài kiểm tra đánh giá khả năng hiếu khí của một người. Chữ V là viết tắt của Thông gió và O2 là viết tắt của oxy. VO2 Max của một người đề cập đến lượng oxy mà một cá nhân có thể sử dụng trong một phút và được biểu thị bằng ml O2/kg-phút. Điều này có nghĩa là mililit oxy trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi phút.

Co thắt cơ tự nguyện: Đây là những cơn co cơ được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương (CNS) và nguồn gốc của sự co cơ là một suy nghĩ có ý thức của não. Một ví dụ về điều này là động tác uốn cong bắp tay.

Số liệu